



IMPORTANT : Ces recommandations ne doivent jamais remplacer la démarche clinique nécessaire en présence de symptômes, de signes ou de facteurs de risque importants pour la santé, qui peuvent en modifier l'application. La clinicienne ou le clinicien doit alors justifier sa conduite dans sa note clinique.

Cancers

**CANCER DU COL UTÉRIN**

- ✓ Femmes (21 à 65 ans) qui sont sexuellement actives ou qui l'ont été par le passé – aux 2 ou 3 ans par le test de Pap*
- ✓ Accompagner la personne dans un processus de [prise de décision éclairée](#)

* L'adoption du dépistage opportuniste fondé sur la détection des VPH oncogènes en première intention a été annoncée en 2022. Cette nouvelle méthode de dépistage sera implantée de manière progressive. Durant la période de transition, le dépistage opportuniste par test de Pap demeure en vigueur.

CANCER DU SEIN

- ✓ Femmes (50 à 69 ans) – aux 2 ans dans le cadre du [PQDCS/ Dépliant](#) pour les patientes
- ✓ Femmes (70 à 74 ans) – recommandé aux 2 ans, sous ordonnance individuelle

CANCER COLORECTAL

- ✓ Hommes et femmes asymptomatiques - stratifier le niveau de risque de cancer colorectal (CCR) suivant les [Algorithmes de prise en charge et de surveillance en fonction du risque et de la condition](#) (risque moyen, p. 5; risque légèrement et modérément accru, p. 7)
- ✓ Promouvoir de [saines habitudes de vie](#) dans le but de prévenir le CCR
- ✓ Dépister le CCR par [test de RSQSi](#) aux 2 ans chez les personnes de 50 à 74 ans (risque moyen) ou de 40 à 74 ans (risque légèrement accru) si elles y consentent après une prise de décision éclairée. La coloscopie en première intention est réservée aux cas à risque modérément accru ou élevé de cancer
- ✓ Si la personne est indécise, la référer au site [Dépistage du CCR](#) pour nourrir sa réflexion d'ici à sa prochaine visite

CANCER DE LA PROSTATE

Aucun dépistage systématique chez les hommes qui ne sont pas à risque élevé (ex.: histoire familiale de cancer de la prostate ou ascendance afro-américaine). Le dépistage par le dosage sanguin de l'antigène prostatique spécifique (APS) s'applique si les conditions suivantes sont remplies:

- ✓ être âgé de 55 à 69 ans;
- ✓ avoir une espérance de vie de plus de 10 ans;
- ✓ maintenir le désir d'être testé après avoir reçu l'information relative aux avantages et aux risques du dépistage. (INESS 2018)

CANCER DU POUMON

Hommes et femmes (55 à 74 ans) qui fument ou ont arrêté de fumer depuis moins de 15 ans ET qui ont fumé pendant au moins 20 ans en excluant les périodes d'abstinence:

- ✓ Offrir de participer au dépistage du cancer du poumon par tomomodensitométrie à faible dose de radiation (TAFD). Toute personne du Québec déterminée admissible par le Centre de coordination peut y participer, mais le dépistage s'effectue exclusivement dans les [centres hospitaliers universitaires et régionaux participants](#)
- ✓ Si la personne accepte, remplir le formulaire [Demande de référence: dépistage du cancer du poumon](#)
- ✓ Si la personne est indécise, lui remettre les coordonnées du Centre de coordination du projet (tél.: 1 844 656-4312; courriel: dépistagecancerpoumon@ssss.gouv.qc.ca) pour vérifier son admissibilité et discuter des [avantages et inconvénients](#) du dépistage

Santé osseuse

**FRACTURES DE FRAGILISATION ASSOCIÉES À L'OSTÉOPOROSE**

- ✓ Dépister uniquement les personnes sans diagnostic d'ostéoporose et qui ne sont pas déjà sous médication pour prévenir les fractures de fragilisation (ex.: bisphosphonate);
- ✓ Femmes : dépister de 65 ans à 90 ans (pas avant);
- ✓ Hommes : ne pas dépister de 40 à 69 ans. Le dépistage de 70 à 90 ans est laissé au jugement des cliniciens (données probantes de très faible qualité);
- ✓ Évaluer le risque de fracture de fragilisation en utilisant l'[outil d'aide pour une prise de décision partagée \(FRAX\)](#) sans y inclure la densité minérale osseuse (FRAX sans DMO);
- ✓ Si le niveau de risque est $\geq 10\%$ ou selon le jugement clinique, discuter avec la personne des [avantages et inconvénients](#) de prendre une médication préventive. Si la personne est favorable, prescrire une ostéodensitométrie (ODM) et intégrer la densité du col fémoral (score T ou g/cm²) dans un FRAX avec DMO. Si la personne est toujours favorable, prescrire un bisphosphonate oral (une période d'au moins 5 ans est recommandée) et contrôler l'ODM 3 ans après l'arrêt. Si la personne refuse la médication, réévaluer le risque (FRAX avec DMO) après 3 à 5 ans.

- ✓ S'assurer d'un apport alimentaire suffisant de [vitamine D et de calcium. Les suppléments, seuls ou combinés, ne préviennent pas les fractures](#) sauf chez les personnes déficientes en vitamine D vivant en établissement. Les personnes ≥ 51 ans qui ne consomment pas d'aliments contenant de la vitamine D tous les jours peuvent bénéficier d'un supplément de 400 UI (10 g) par jour. Les personnes sous médication préventive peuvent bénéficier de suppléments individualisés de vitamine D et de calcium.
- ✓ Recommander la pratique d'activités physiques régulières et diversifiées, l'abandon du tabagisme et la réduction ou l'abstinence de l'alcool.
- ✓ Les personnes considérées à risque de chute peuvent être référées aux programmes [PIED](#) ou [VIACTIVE](#).